

Reguły *paliwo cyklu*

Sztywne reguły żywieniowe są kluczowym czynnikiem podtrzymującym bulimię. „Nie wolno X”, „muszę tylko Y”. Marlatt 1985: *abstinence violation effect*. Cel: identyfikacja i stopniowe podważanie.

CZAS: 30 min · identyfikacja + plan Etap 2 CBT-E (sesje 8–12) · po regularnym jedzeniu

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Marlatt (1985); Polivy & Herman (1985)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **mechanizm reguł** + *abstinence violation effect* (sekcja 1), **typowe kategorie** (sekcja 2). Sekcja 3 — Twoja lista. Sekcja 4 — plan podważania.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Reguły żywieniowe w bulimii są **sztywne, specyficzne, często nierealistyczne**. Typowe: „nie wolno po 18:00”, „nie wolno węglowodanów”, „zawsze muszę wiedzieć kalorii”. Fairburn (2008): reguły żywieniowe są **kluczowym czynnikiem podtrzymującym** bulimię. Mechanizm: reguła → próba przestrzegania → naruszenie → „wszystko zepsute, skoro już zjadłam, to zjem WSZYSTKO” (*abstinence violation effect*, Marlatt 1985) → epizod. Polivy & Herman (1985): osoby z wysoką restrykcją zjadają **3x więcej** po „łamaniu” reguły. Bulimia *nie jest brakiem dyscypliny* — jest *nadmiarem dyscypliny*. Cel: **mniej reguł, więcej elastyczności** — wytyczne zamiast zakazów.

01 ● Mechanizm *abstinence violation effect*

Reguła: „Nie wolno czekolady” → **Naruszenie:** zjedzenie jednej kostki → **Myślenie wszystko-albo-nic:** „dzień zepsutej, zasada złamana” → **Counter-regulation:** „skoro już zepsute, to mogę zjeść WSZYSTKO” → **Epizod:** zjedzenie całej tabliczki + reszty zapasów → wstyd → kompensacja → *jeszcze surowsza reguła od jutra* → cykl.

Wniosek empiryczny (Polivy & Herman 1985, *counter-regulation*): w eksperymencie z „milkshake preload” osoby z wysoką restrykcją żywieniową, którym dano duży koktajl mleczny (rzekomo „łamanie” diety), zjadały następnie **3x więcej** lodów niż osoby z niską restrykcją. Restrykcja nie chroni przed epizodem — *napędza go*. To *kluczowa* informacja: paradoks reguł.

02 = Typowe kategorie reguł żywieniowych

ZAKAZY POKARMOWE

„Nie wolno węglowodanów / cukru / pieczywa / czekolady / fastfoodu”. Konkretnie grupy produktów na liście zakazów.

REGUŁY CZASOWE

„Nie po 18:00 / 19:00 / 20:00”, „Tylko 3 posiłki dziennie”, „16:8”, „Nie 4 godziny po treningu”.

REGUŁY ILOŚCIOWE

„Tylko 1200 kcal”, „Małe porcje”, „Tylko jedna porcja”, „Nie więcej niż X gramów”.

REGUŁY KONTEKSTOWE

„Tylko jak jestem sama”, „Nie mogę jeść przy innych”, „Nie w restauracji”, „Tylko w kuchni”.

REGUŁY POZNAWCZE

„Zawsze muszę wiedzieć kalorii”, „Muszę zaplanować dzień”, „Nie mogę zjeść spontanicznie”.

REGUŁY KOMPENSACYJNE

„Po posiłku muszę poćwiczyć”, „Jeśli zjem X, to muszę głodować”, „Najpierw cardio, potem jedzenie”.

03 \ Moja lista reguł żywieniowych

Spisz **wszystkie** reguły, jakie masz wokół jedzenia. Typowo pacjenci mają 15–30 reguł, choć wielu jest nieświadomych. Świadomość to pierwszy krok do podważania.

REGUŁA (JAK JĄ SŁYSZĘ)	KATEGORIA	SZTYWNOŚĆ 0–10

04 Plan stopniowego podważania

PYTANIA PODWAŻAJĄCE

„Skąd ta reguła?”, „Co stanie się, gdy ją złamię?”, „Czy inni ludzie mają tę regułę?”, „Co mówią dane / fakty?”.

EKSPERYMENTY BEHAWIORALNE

Świadome *złamanie* reguły w bezpiecznym kontekście. Obserwacja: czy katastrofa się wydarzyła? Z reguły nie.

OD NAJMNIEJ SZTYWNEJ

Zacznij od reguły 4–5 (sztywność średnia), nie od 9–10. Sukcesy budują kapitał do trudniejszych.

ELASTYCZNE WYTYCZNE

Cel: nie *brak* zasad, lecz *elastyczne* wytyczne. „Zazwyczaj jem 3+2”, nie „nigdy więcej / mniej”.

Klucz: reguły żywieniowe są *paliwem cyklu bulimii*. Marlatt (1985) opisał *abstinence violation effect* oryginalnie dla uzależnień — gdy alkoholik wypije „jeden kieliszek”, często idzie do tygodniowego picia. Ten sam mechanizm działa w bulimii: „jedno ciastko” prowadzi do całej tabliczki + opakowania. Polivy & Herman (1985) empirycznie potwierdzili w laboratorium — osoby z wysoką restrykcją zjadają **3x** więcej po „złamaniu” reguły. Fairburn (2008): w CBT-E praca z regułami żywieniowymi jest **obowiązkowym** elementem etapu 2. Bez niej cykl pozostaje, nawet gdy regularne jedzenie 3+2 zostało wprowadzone. Pacjenci często obawiają się: „jeśli znikną reguły, stracę kontrolę”. Empirycznie odwrotnie: *wraz ze spadkiem reguł, spada liczba epizodów*. Bo to reguły, nie kontrola, generują epizody. Cel końcowy: nie *brak* zasad, lecz **elastyczne wytyczne** — „zazwyczaj jem 3+2”, „preferuję X, ale czasem Y”. To różnica między *regułami* a *preferencjami*. Reguły są sztywne, preferencje elastyczne. Po 6–12 tygodniach pracy większość pacjentów odczuwa **znaczącą ulgę** — bo nie ma już z czym walczyć.